2.2.2 입원환자 초기평가 / 재평가			
규 정 번 호	2.2.2	제 정 일	3주기 규정집 제정
관련 인증기준	2.2.2 입원환자 초기평가 / 재평가	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	진료부, 간호부, 영양실	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거			

▣ 목적 (Purpose)

의료진은 정확한 치료, 환자의 요구에 맞는 서비스 제공을 위해 초기평가를 수행하고 치료에 대한 반응을 파악하고 지속적 치료와 퇴원을 계획하기 위해 이를 기록하며, 환자진료를 담당하는 직원과 공유한다.

▣ 용어정의 (Definition)

· 입원환자 초기평가 : 환자가 입원했을 때 환자의 상태를 파악하여 입원기록지, 간호기록지에 기록하는 행위

· 영양상태평가 : 입원 시 의료진 (의사 혹은 간호사) 또는 영양사가 환자의 키, 몸무게, 체중감소, 삼킴장애 여부 등을 근거로 한 영양상태를 파악하는 것

▣ 정책 (Policy)

1. 입원환자 초기평가에 대한 규정이 있다.
2. 의학적 초기평가를 24시간 이내 수행하고 기록한다.
3. 간호 초기평가를 24시간 이내 수행하고 기록한다.
4. 영양 초기평가를 수행하고 기록한다.
5. 입원환자의 의학적 재평가에 대한 규정이 있다.
6. 입원환자의 의학적 재평가를 수행하고 기록한다.
7. 환자평가 기록을 환자 진료를 담당하는 직원과 공유한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

※ 모든 기록에는 환자의 정보 작성일시와 작성자 서명이 포함되어야 한다.

※ 입원 시 환자상태 파악을 위해 필요한 초기검사를 수행한다. 단, 입원 전 1개월 이내 시행한 기존 검사 결과가 있는 경우 해당 결과를 확인하는 것으로 대체할 수 있다.

※ 초기검사란 혈액검사, 소변검사, 영상검사 등을 의미한다.

1. 초기평가 대상

가. 진료과 입원 환자 대상으로 초기평가를 수행한다.

2. 초기평가 종류 및 수행자, 수행 시기

가. 의사는 입원 24시간 이내(주말 및 공휴일 포함)에 환자평가를 시행하고 입원 기록지에 기록한다.

나. 간호사는 입원 24시간 이내(주말 및 공휴일 포함)에 환자평가를 시행하고 간호정보조사지에 기록한다.

다. 영양사는 입원 48시간 이내 (주말, 공휴일 제외)에 환자평가를 시행하고 영양 초기평가지에 기록한다.

3. 초기평가 내용

가. 의학적 초기 평가내용

1) 환자 이름과 등록번호
2) 입원시 진료과
3) 주 호소
4) 현재 및 과거 병력
5) 가족력
6) 신체검진
7) 초기검사
8) 추정진단
9) 작성일시
10) 작성자 서명 등

나. 간호 초기 평가내용 : 간호정보 조사지에 기록한다.

1) 환자 이름과 등록번호
2) 일반정보(general information) : 입원일시, 환자이름, 생년월일, 키, 몸무게, 성별, 나이 등
3) 입원정보(admission related information) : 입원경로 및 방법, 주 호소, 최초(최근)발병일
4) 환자 과거력(병력) 및 가족력
5) 진료정보 : 최근투약, 입원 및 수술경험, 알러지 여부 등
6) 신체사정 : 의식상태, 계통별 문진, 수면장애 여부, 통증, 배변 / 배뇨 습관, 일상생활수행능력, 정서 상태 등
7) 문화적, 종교적 특수성은 간호기록한다.
8) 작성 일시
9) 작성자 서명 등

다. 영양 초기 평가내용

1) 환자의 키, 몸무게, 체중감소, 삼킴장애 여부 등을 확인하여 입원 후 48시간 이내에 영양초기평가지에 기록한다.
2) 임상검사 소견을 근거로 영양상태를 확인한다.

4. 입원환자 초기평가 정보 공유

가. 초기평가의 내용은 환자 진료를 담당하는 직원들과 의무기록 접근 권한 내에서 전자의무기록(EMR/OCS)를 통하여 공유한다.

나. 공유 대상 : 의사, 간호사, 간호조무사, 영양사, 물리치료사, 재활치료사, 사회복지사, 약사, 방사선사

5. 입원환자의 의학적 재평가

가. 의학적 재평가 대상 및 주기

1) 입원일로부터 30일이 초과한 환자는 의학적 재평가를 실시하고 경과기록에 기록한다.
2) 재평가 이후 매월 1회 정기적으로 환자상태에 대해 인지할 수 있도록 경과기록에 재평가를 기록한다.
3) 전과 시 의학적 재평가를 실시하고 재평가일로부터 30일이 초과하여 재평가하여 경과기록에 기록한다.

나. 의학적 재평가 내용

1) 환자의 주 호소 및 현 병력
2) 환자의 신체검진 결과 및 의식수준
3) 치료 경과에 따른 문제
4) 현(現) 치료계획 및 필요시 치료계획 변경(의뢰 및 전원 포함)

다. 의학적 재평가 기록 공유

1) 담당의가 작성한 의학적 재평가의 내용은 환자 진료를 담당하는 직원들과 의무기록 접근 권한 내에서 전자의무기록(EMR/OCS)를 통하여 공유한다.
2) 공유 대상 : 간호사, 간호조무사, 영양사, 물리치료사, 재활치료사, 사회복지사, 약사, 방사선사

▣ **부록 (Appendix)**

1. 입원기록지
2. 간호정보 조사지
3. 영양 초기평가

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

부록1. 입원기록지

환자번호: 성명: 성별/나이: 진료과: 병동/병실:	**입 원 기 록 지** 입원일자:
* C/C * P/I * P/Hx * F/Hx * ROS * P/E * Impression * Plan	

부록2. 간호정보 조사지

간호정보 조사지

등록번호		환자성명		성별/나이	/	입원일시	

입원상태		
입원1개월전 거주지	☐집(재가 장기요양 서비스를 받으면서) ☐집(재가 장기요양 서비스를 받지 않으면서)	
	☐요양시설/그룹홈 ☐급성기 병원 ☐요양병원 ☐정신병원/정신시설 ☐기타	
입원방법	☐도보 ☐휠체어 ☐구급차 ☐기타 ( )	
신체계측	신장 cm 체중 kg 다른 신체적 특징	
활력징후	혈압 / mmHg 맥박 /mm 체온 ℃ 호흡 /min	

병력 및 입원정보				
현재주증상	주증상 : 발병일 :			
과거병력	☐고혈압 ☐당뇨 ☐결핵 ☐관절염 ☐기타( )			
입원경험	☐없음 ☐있음 :	수술병력	☐없음 ☐있음 :	
최근투약내용	☐없음 ☐있음 (지참약: ☐없음 ☐있음)			
알러지유무	☐없음 ☐있음 :			
가족병력	☐없음 ☐있음(☐고혈압 ☐당뇨 ☐암 ☐기타)			
가족관계	☐배우자(있음.없음) ☐자녀(남 녀) ☐부양가족( )			
교육정도	☐무학 ☐한글해독 ☐초졸 ☐중졸 ☐고졸 ☐대졸			
직업	☐본인 또는 배우자( ) ☐부양가족( )			
종교	☐무교 ☐불교 ☐기독교 ☐천주교 ☐기타( )			

신체적 정보		
피부	피부상태	☐정상 ☐비정상부위: ☐발진☐물집☐흉터☐상처☐반점☐욕창☐발한☐건조☐소양감☐불결함
	피부색깔	☐정상 ☐비정상(☐창백 ☐홍조 ☐청색증 ☐황달) 부위:
호흡기계	호흡기장애	☐없음 ☐있음 (☐호흡곤란 ☐가래 ☐기침 ☐청색증 ☐이상호흡음 ☐기관절개관)
순환기계	순환기장애	☐없음 ☐있음 (☐심계항진 ☐흉통 ☐청색증 ☐호흡곤란 ☐식은땀 ☐부정맥 ☐심잡음)
	부종	☐없음 ☐있음(☐전신 ☐사지 ☐상지 ☐하지 ☐얼굴 ☐안검 ☐기타)
신경계	시력장애	☐없음 ☐있음(좌 /우)
	청력장애	☐없음 ☐있음(☐좌/☐우: ☐청력저하☐이명☐청각상실☐기타)
	신경근육	☐이상없음 ☐무감각/저림 마비: ☐없음 ☐있음 부위(상지: ☐좌/☐우,하지 ☐좌/☐우)
	통증	☐없음 ☐있음: 부위( )
소화기계	소화기장애	☐없음 ☐있음 (☐연하곤란 ☐오심 ☐구토 ☐소화장애 ☐복부팽만 ☐복부동통 ☐기타)
치아상태	☐양호 ☐의치(☐상/☐하) ☐결손 ☐기타( )	

활동상태	□자유로움 □자유롭지 못함 □용변조력 / 일주일에 30분이상 운동하는 횟수:
신체적기형	□없음 □있음(부위:)
의식, 정서상태	
의식정도	□명료 □혼돈 □반의식 □무의식(통증에 반응:□있음 □없음)
지남력	□장소(□있음/□없음) □시간(□있음/□없음) □사람(□있음/□없음)
정서상태	□안정 □불안 □우울 □분노 □기타
의사소통	□원만함 □곤란함 □불가능함 □기타:
병에대한인식	□있음 □없음
습관정보	
수면습관	□수면장애(□있음/□없음) □수면제 복용(□무 □유) □취침시간: 시 □수면시간:
위생상태	□양호 □보통 □불량 □목욕(회/월)
영양상태-식욕	□양호 □보통 □나쁨 □식습관:
영양상태-체중	□변화없음 □감소(kg/기간) □증가(kg/기간)
음식기호	□선호하는 반찬:
	□기피하는 반찬:
음주	□안함 □함(종류: 양: 병/회, 횟수: 회/일)
흡연	□안함 □함(갑/일, 기간: 년)
배설기능	□Self voiding □Diaper □Foley cath. □기타
대변	횟수: 회/ 일 □정상 □설사 □변비 □기타:
소변	횟수: 회/ 일 □정상 □실금 □빈뇨 □기타

건강생활 습관	질문	답변
	a. 담배를 피우십니까?	□ 0. 아니오 □ 1. 예
	b. 술을 자주 마십니까?	□ 0. 아니오 □ 1. 예
	c. 주 4일 이상, 한번에 30분 이상 운동을 합니까?	□ 0. 아니오 □ 1. 예
	d. 하루 세끼 식사를 꼬박꼬박 챙겨 먹습니까?	□ 0. 아니오 □ 1. 예

입원시 간호 및 교육 내용	
입원시 준비물	
개인준비 보조기구	□없음 □있음 (□의치□안경□보청기□보족□목발□지팡이□pace maker□에어매트 □공기방석□휠체어)
보호자 면회 (8시 이후 면회 제한) 및 식사시간 안내	
귀중품 관리 및 도난방지	
과거낙상	□없음 □있음,(낙상사정점수:)
현재 욕창	□없음 □있음(등급:)
통증	□없음 □있음(통증점수:)
지역사회 복지 체계	
장기요양등급 신청여부	□해당사항 없음 □미신청 □신청중 □신청하였으나 못받음 □등급내자 □등급외자
등급	□1등급 □2등급 □3등급 □4~5등급 □인지지원 등급 □확인불가

이용중 또는 이용하였던 서비스	☐주야간 보호 ☐방문요양 ☐방문간호 ☐ 방문목욕 ☐단기보호 ☐복지용구 구입 및 대여 ☐시설 입소 ☐기타	
장기요양서비스 희망 여부	☐예 ☐ 아니오 *장기요양 등급 미신청 또는 신청하였으나 인정 못하는 경우	
사회환경 선별 조사	☐응답거부	
☐식사준비, 간병등의 도움을 줄수 있는 사람이 없음 ☐예 ☐아니오		
☐전기,수도등 공과금 미납으로 서비스 중단 고지를 받은 적 있음 ☐예 ☐아니오		
☐안정적으로 거주할 집이 없어 노숙을 한 적 있음 ☐예 ☐아니오		
☐병원비, 월세등 주거비, 난방비 등 비용 지불이 어려운 적이 있음 ☐예 ☐아니오		
☐교통 수단 부족으로 진료, 복지관 등 외출이 어려웠던 적이 있음 ☐예 ☐아니오		
☐먹을것이 없거나 학대를 받는 등 긴급하게 도움이 필요한적이 있음 ☐예 ☐아니오		
ADL	식사하기	☐완전자립 ☐감독필요 ☐약간의 도움 ☐상당한도움 ☐전적인 도움
	체위변경	☐완전자립 ☐감독필요 ☐약간의 도움 ☐상당한도움 ☐전적인 도움
	옮겨앉기	☐완전자립 ☐감독필요 ☐약간의 도움 ☐상당한도움 ☐전적인 도움
	화장실 사용	☐완전자립 ☐감독필요 ☐약간의 도움 ☐상당한도움 ☐전적인 도움
경제상태		
사회사업실 연결 요청 여부 ☐유 ☐무		
정보제공자	성명: 서명 (관계:)	설명간호사 성명: 서명
연락처		
기타		

부록3 영양 초기평가

영양초기평가
(nutrition intial evaluation)

NATURE 네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

병 실		환자이름		등록 번호	
입원일자		상담일자		상담영양사	

신체계측/임상정보

1. 신체계측(□ ±10%전후 - 0, □±10%~30%전후 - 3, □±30% 이상 - 5)

항목	수치	항목	수치
신장	cm	현재체중	kg
표준체중	kg	BMI(체질량지수)	

2.신체 증후: □ 매우여윔 □ 여윔 □ 비만 □ 부종 □ 복수 □ 기타:

체중감소 여부 □ 무 □ 유(2점) (최근3개월이내)

3.임상정보 (보유병력)

□ 고혈압 □ 당뇨 □ 비만 □ 저혈압 □ 뇌경색 □ 치매 □ 폐질환 □ 신장질환 □ 변비
□ 기타 :

식생활/활동도

식사형태: □일반식 (0) □갈은식 (2) □죽 (2) □미음(2) □경관영양(2) □기타: (2)
※ 기타 : 체중조절식, 당뇨식, 저염식, 고단백식 등 질환별 식이

식사 섭취 상태: □ 양호(⅔~1⅓ -0) □불량(⅓~⅔,1⅓~⅔ -3) □심한불량(⅓이하, 1⅔이상 -5)

식사 시 문제점

저작상태	연하상태	건강상태
□무엇이든 씹을 수 있다 -0 □부드러운 것은 씹을 수 있다. -1 □빠는 것이라면 가능하다. -3 □씹을 수 없다. /씹을 입이 없다 -5	□무엇이든 삼킬 수 있다. -0 □가끔 사레 들린다. -1 □자주 심하게 사레 들린다. -3 □삼킬 수 없다. -5	□소화불량-2 □식욕저하-2 □우울증-2 □변비-2 □설사-2 □치매 -2 □구토-2 □승복감-2 □불규칙한 식사 -2 □편식-2 □해당사항 없음 -0

식품알레르기/유당불내증 □무 □유-2
식사속도 □보통 -0 □빠름-2 □느림-2

생화학자료: Albumin : Hb:

영양평가

1. 식습관 및 평소 식사섭취상태에 대한 평가
   ·장 점 :
   ·문제점 :
2. 영양권장량
   ·기준체중(□표준/□현재/□조정) : kg, 에너지: kcal
   ·활동도 : □가벼운 활동 □ 보통 활동 □심한 활동
3. 영양총평
   ①총점: 점
   ②상태비교 : □ 양호(0~10) □ 불량 (11~20) □ 심한불량(21~30)

※양호 : 건강 및 섭식, 영양 등에 문제가 없는 상태
불량 : 건강 및 섭식, 영양 등에 문제가 있어 세심한 관찰이 요구되는 상태(여윔, 비만, 부종 포함)
심한불량: 극도의 건강 및 섭식, 영양 등에 문제가 있어 의료적 처치가 필요한 상태(극도의 여윔, 비만, 부종 포함)

영양관리계획

□불량, 심한 불량인 경우 의사에게 보고
□교육 자료 제공
□기타 영양사: (서명)